

Roteiro Operacional - Apresentacao Final TCC MedIT

Roteiro Operacional — Apresentação Final TCC MedIT

Estrutura Geral

Item	Definição
Duração	20 minutos (~6 min slides + ~14 min demonstração ao vivo)
Equipe	7 integrantes; cada um conduz um único bloco e não retorna
Ordem linear	Brenda → Evellin → Rafael Vieira → Jonatas → Matheus → Rafael Silva → Victor (cada um fala uma vez , sem retorno)
Fases	Slides (Brenda, Evellin, Rafael Vieira) → Sistema (Jonatas, Matheus, Rafael Silva, Victor)
Ordem da demo	Administrador → Enfermeiro → Médico → Paciente
Mensagem central	Plataforma de apoio ao fluxo hospitalar, com controle por perfil e sugestões por regras — sem substituir o profissional
Regra de ouro (admin)	Todo usuário operacional pertence a uma unidade ; listagens do admin são da unidade dele

Cronograma Resumido

Bloco 1 — Slides (~6 min)

Horário	Integrante	Tópicos
00:00–02:50	Brenda Silva	Slides: abertura, equipe, problema, motivação, objetivo, impacto
02:50–04:20	Evellin Simões	Slides: arquitetura e módulos
04:20–06:00	Rafael Vieira	Slides: fluxo de status, segurança, IA simbólica

Bloco 2 — Demonstração ao vivo (~14 min)

Horário	Integrante	Tópicos
06:00–11:15	Jonatas Lima	Login (entrada + perfil admin), dashboard, médicos CRUD+detail, enfermeiros CRUD+detail, pacientes list+detail+edit, config, unidades parceiras, medicamentos
11:15–13:45	Matheus Chagas	Enfermeiro: dashboard/fila, triagem completa, histórico triagens, config
13:45–16:15	Rafael Silva	Médico: dashboard/fila, atendimento, sugestões, finalizar atendimento, histórico, config
16:15–20:00	Victor Campos	Paciente: sign-up (opcional), pré-cadastro, confirmar chegada, config, encerramento

Possíveis Perguntas da Banca

Pergunta	Resposta sugerida
Dois profissionais no mesmo caso?	Claim atômico na fila; API valida status e se já há responsável.
Admin vê médicos de outras unidades?	Não; listagens filtradas pelo <code>unitId</code> do token.
Por que admin primeiro e paciente por último?	Da governança operacional ao impacto na ponta (usuário final).
É diagnóstico automático?	Não; sugestão por regras com % de compatibilidade; decisão é do médico.
LGPD?	Controle por perfil, minimização de exposição; conformidade plena depende da instituição.
Só dados de seed?	Demonstramos criação ao vivo (médico/enfermeiro no admin, pré-atendimento do paciente).

Script Completo

Formato de cada cena: **Tela** (onde estar) → **Ação** (o que fazer, clique a clique) → **Fala** (texto integral, com a tela indicada em destaque).

Linhas `[APOIO]` são para quem opera o notebook, sem microfone.

Bloco 1 — Slides

| Brenda Silva (2 minutos e 50 segundos)

Cena 1 — Abertura

- **Tela:** Slide de capa (projetor; notebook pode estar em standby ou com login ao fundo, sem foco).
- **Ação:** Posicionar-se de frente para a banca. Olhar para os avaliadores. Não mexer no computador ainda.
- **Fala:** “Boa noite, professores e professoras. Somos a equipe do Trabalho de Conclusão de Curso em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e hoje apresentamos o **MedIT** — uma plataforma web de apoio à triagem e à organização do fluxo hospitalar.”

Cena 2 — Equipe

- **Tela:** Slide com nomes dos sete integrantes.
- **Ação:** Apontar o slide, citar cada nome com uma palavra sobre a área (frontend, backend, regras de negócio, etc.), sem ler lista mecanicamente.
- **Fala:** “O time é formado por Brenda Silva, Evellin Simões, Jonatas Lima, Matheus Chagas, Rafael Silva, Rafael Vieira e Victor Campos. Cada um conduz um bloco da apresentação, em sequência, para mostrar o sistema completo em vinte minutos.”

Cena 3 — Problema

- **Tela:** Slide “Problema”.
- **Ação:** Pausa breve após o título. Gestualizar fila / sobrecarga se couber.
- **Fala:** “Partimos de um problema real nas unidades públicas: superlotação, filas com pouca previsibilidade, retrabalho na coleta de informações e falta de visibilidade operacional para quem gerencia o dia a dia.”

Cena 4 — Motivação e objetivo

- **Tela:** Slide “Objetivo” (ou motivação + objetivo no mesmo slide).
- **Ação:** Transição de slide com calma.
- **Fala:** “Nosso objetivo foi construir uma solução que organize a jornada do atendimento de ponta a ponta: cadastro, triagem, consulta e indicadores, com dados estruturados, controle por perfil de acesso e um mecanismo de sugestões baseado em regras — sempre como **apoio** ao profissional, nunca como substituição da decisão clínica.”

Cena 5 — Impacto e passagem

- **Tela:** Slide “Impacto esperado”.
- **Ação:** Manter slide visível. Olhar para Evellin.
- **Fala:** “Esperamos reduzir fricção na entrada do paciente, diminuir retrabalho na triagem e dar base objetiva para a gestão da unidade. Com o contexto apresentado, a Evellin mostra a arquitetura do sistema.”
- **[APOIO]** Evellin assume com slide de arquitetura.

| Evellin Simões (1 minuto e 30 segundos — slides)

Cena 1 — Arquitetura

- **Tela:** Slide “Arquitetura” (diagrama frontend / API / MongoDB).
- **Ação:** Explicar o diagrama com o dedo ou laser; não abrir o sistema ainda.
- **Fala:** “O MedIT é um monorepo: **frontend** em React com Vite, **backend** em Express com TypeScript e **persistência** em MongoDB. A comunicação é via API REST, com autenticação JWT — access token e refresh token — e senhas armazenadas com hash.”

Cena 2 — Módulos e passagem

- **Tela:** Slide “Módulos” ou lista: Admin, Enfermagem, Médico, Paciente.
- **Ação:** Enumerar os quatro blocos que a banca verá na demonstração. Olhar para Rafael Vieira.
- **Fala:** “Na demonstração percorremos o sistema na ordem operacional: primeiro o **administrador da unidade**, depois **enfermagem**, **médico** e, por fim, o **paciente** — fechando com a experiência de quem inicia o atendimento fora da unidade. O Rafael Vieira consolida o fluxo técnico antes de entrarmos ao vivo.”
- **[APOIO]** Rafael Vieira assume com slides de fluxo, segurança e IA simbólica.

Rafael Vieira (1 minuto e 40 segundos — slides)

Cena 1 — Fluxo de estados

- **Tela:** Slide com fluxo: `onTheWay` → `waitingTriage` → `inTriage` → `waitingAttendance` → `inAttendance` → `attendanceCompleted`.
- **Ação:** Percorrer cada seta com o dedo.
- **Fala:** “O atendimento não é uma sequência de telas soltas: é uma **máquina de estados**, com histórico em `changesHistory` para auditoria — da chegada do paciente à conclusão do episódio.”

Cena 2 — Segurança e isolamento

- **Tela:** Slide ou diagrama: perfil + unitId + titularidade (doctorId, nurselId, patientId).
- **Ação:** Reforçar três camadas.
- **Fala:** “A segurança combina **papel** — admin, enfermeiro, médico, paciente —, **unidade** e **titularidade** do episódio. Por isso o médico A não abre atendimento do médico B, e o administrador enxerga apenas a própria unidade.”

Cena 3 — IA simbólica e limites

- **Tela:** Slide “IA simbólica” ou trecho do serviço (opcional).
- **Ação:** Tom firme, olhar para a banca.
- **Fala:** “As sugestões calculam compatibilidade por pesos de sintomas — explicável e reproduzível. O protótipo não integra o SUS nem substitui o profissional; é apoio à decisão em ambiente acadêmico.”

Cena 4 — Passagem para a demonstração

- **Tela:** Slide final técnico ou tela de login ao fundo (projeto já aberto no navegador).
 - **Ação:** Fechar apresentação de slides ou alternar para o navegador. Chamar Jonatas ao notebook.
 - **Fala:** “Com o fluxo e as regras de negócio apresentados, o Jonatas abre a demonstração ao vivo pelo perfil administrador da unidade.”
 - **[APOIO]** Deixar o MedIT na **tela de login** (/). Jonatas assume o teclado.
-

Bloco 2 — Demonstração ao vivo

| Jonatas Lima (5 minutos e 15 segundos)

Cena 1 — Entrada no sistema

- **Tela:** Tela de login do MedIT (/) — projeto já aberto no navegador, tema claro ou escuro fixo.
- **Ação:** Mostrar campos “E-mail ou CPF” e “Senha”. Apontar o link “Cadastrar-se” na parte inferior, **sem** clicar ainda.
- **Fala:** “Este é o ponto de entrada do sistema, *na tela de login*. Pacientes podem se cadastrar pela rota pública de sign-up; profissionais e gestores acessam com credenciais vinculadas à unidade. Entro agora como administrador da unidade.”

Cena 2 — Login administrador

- **Tela:** Tela de login (/).
- **Ação:** Clicar no campo de identificador. Informar o usuário administrador da unidade. Clicar em senha. Informar a senha. Clicar no botão de entrar (submit do formulário).
- **Fala:** “Com o perfil administrador, *na tela de login*, represento a gestão operacional local — não a rede inteira, e sim **uma** unidade específica.”

Cena 3 — Dashboard

- **Tela:** Dashboard do administrador (/auth/dashboard) — menu lateral com Dashboard, Médicos, Enfermeiros, Pacientes, Unidades parceiras, Medicamentos.
- **Ação:** Aguardar carregar os cards. Apontar, da esquerda para a direita (ou na ordem visual): Entradas, Em atendimento, Atendidos, Ocupação.
- **Fala:** “No *dashboard do administrador*, a gestão enxerga indicadores da **própria unidade**: quantos entraram no período, quantos estão em atendimento, quantos foram concluídos e a ocupação em relação à capacidade nominal.”

Cena 4 — Filtro de período

- **Tela:** Dashboard — barra superior com seletor de período (dia / semana / mês / ano) e calendário de data de referência.
- **Ação:** Clicar no seletor de período. Escolher “Semana”. Clicar no calendário. Selecionar a data de hoje (ou uma data da semana corrente). Aguardar recarregar cards e gráfico.
- **Fala:** “Altero o recorte temporal para mostrar que os números não são estáticos: entradas, fila e gráfico respondem ao período e à data de referência escolhidos.”

Cena 5 — Gráfico e fila (rápido)

- **Tela:** Dashboard — gráfico “Atendimentos por tempo” e card da fila administrativa.
- **Ação:** Rolar levemente se necessário. Apontar o gráfico. Apontar a fila sem abrir tela cheia (a menos que sobre tempo).
- **Fala:** “O gráfico distribui os atendimentos no tempo; a fila ao lado reflete o mesmo período no perfil administrador, alinhando leitura gerencial e operação.”

Cena 6 — Listagem de médicos

- **Tela:** Menu lateral → clicar em **Médicos** (/auth/doctors).
- **Ação:** Aguardar tabela carregar. Passar o mouse sobre uma linha. Apontar colunas (nome, contato, ações).

- **Fala:** “Em *Médicos*, o que vocês veem não é todos os médicos do sistema: é a listagem dos médicos da unidade do administrador logado. Cada usuário operacional carrega um `unitId` no token, e o backend filtra por essa unidade.”

Cena 7 — Criar médico

- **Tela:** **Médicos** — botão **Adicionar médico(a)** no canto superior direito.
- **Ação:** Clicar em **Adicionar médico(a)**. Preencher no modal: nome (ex.: “Dr. Demo Banca”), identificador de login, senha, CRM, especialização e demais campos obrigatórios. Clicar em **Continuar** / salvar conforme o fluxo do modal. Aguardar mensagem de sucesso e linha nova na tabela.
- **Fala:** “Cadastro um médico novo ao vivo para demonstrar que o sistema não depende apenas de dados de seed: a unidade pode incluir profissionais no dia a dia.”

Cena 8 — Editar médico

- **Tela:** **Médicos** — linha do médico recém-criado ou existente.
- **Ação:** Clicar no ícone/botão **Editar** da linha. Alterar um campo visível (ex.: telefone ou consultório). Clicar em **Salvar alterações**. Fechar modal.
- **Fala:** “A edição completa o ciclo de manutenção do cadastro profissional dentro da mesma unidade.”

Cena 9 — Detalhe do médico

- **Tela:** **Médicos** — clicar na linha ou em **Ver detalhes** para abrir `/auth/doctors/:id`.
- **Ação:** Mostrar dados do médico. Apontar card “Último atendimento” ou mensagem de sem atendimentos. Não editar aqui se o tempo apertar.
- **Fala:** “No *detalhe do médico*, consolidamos informações do profissional e o vínculo com atendimentos, apoiando a gestão e a auditoria.”

Cena 10 — Listagem de enfermeiros

- **Tela:** Menu lateral → **Enfermeiros** (`/auth/nurses`).
- **Ação:** Mostrar tabela carregada.
- **Fala:** “A mesma regra vale para enfermeiros: listagem escopada à unidade do administrador.”

Cena 11 — Criar e editar enfermeiro

- **Tela:** **Enfermeiros**.
- **Ação:** Clicar **Adicionar enfermeiro(a)**. Preencher nome, identificador de login, COREN, turno, etc. Salvar. Em seguida, **Editar** o registro e salvar uma alteração simples.
- **Fala:** “Incluo e atualizo um enfermeiro da unidade, mantendo o cadastro operacional sob controle local.”

Cena 12 — Detalhe do enfermeiro

- **Tela:** **Enfermeiros** → abrir detalhe `/auth/nurses/:id`.
- **Ação:** Mostrar tela de detalhes. Voltar com seta ou menu.
- **Fala:** “O detalhe do enfermeiro espelha o do médico: visão consolidada para gestão.”

Cena 13 — Listagem de pacientes

- **Tela:** Menu lateral → **Pacientes** (`/auth/patients`).
- **Ação:** Mostrar alerta informativo no topo: cadastro de pacientes via SignUp. Mostrar tabela de pacientes da unidade.

- **Fala:** “Em *Pacientes*, o administrador consulta e edita quem já está vinculado à unidade. O cadastro inicial do paciente é feito pelo próprio usuário em *Cadastrar-se*, na tela pública — reforçamos isso no bloco final do Victor.”

Cena 14 — Editar paciente e detalhe

- **Tela:** Pacientes.
- **Ação:** Clicar **Editar** em um paciente existente. Alterar campo permitido (ex.: condições ou alergias). Salvar. Abrir **detalhe** `/auth/patients/:id`. Mostrar dados e último atendimento.
- **Fala:** “A gestão pode atualizar dados cadastrais sem apagar o histórico clínico do paciente na unidade.”

Cena 15 — Configurações do admin

- **Tela:** Menu lateral inferior → botão **Configurações** (ícone de engrenagem) — abre **ConfigModal**.
- **Ação:** Mostrar abas/campos de nome, contato e opção de alteração de senha. Alterar telefone ou apenas exibir o fluxo **sem** salvar alteração sensível, se preferir na demo.
- **Fala:** “Todo perfil autenticado mantém seus dados de conta em *Configurações*, com validação na API.”

Cena 16 — Unidades parceiras

- **Tela:** Menu lateral → **Unidades parceiras** (`/auth/units`).
- **Ação:** Mostrar grid de cards de unidades. Apontar nome, endereço e status (Aberto/Fechado).
- **Fala:** “Aqui consultamos a rede de unidades parceiras — útil quando um medicamento não está disponível na unidade local.”

Cena 17 — Medicamentos da unidade

- **Tela:** Menu lateral → **Medicamentos** (`/auth/units/:unitId/medications`) — o sistema redireciona para a unidade do admin.
- **Ação:** Aguardar grid de cards de medicamentos. Apontar nome, categoria, tag de disponibilidade e quantidade em estoque.
- **Fala:** “O estoque exibido é da **unidade do usuário logado**. Administrador, médico, enfermeiro e paciente enxergam medicamentos no contexto da unidade, com regras de permissão diferentes.”

Cena 18 — Cadastrar ou editar medicamento

- **Tela:** Medicamentos.
- **Ação:** Clicar **Adicionar Medicamento**. Preencher nome (ex.: “Medicamento Demo Banca”), categoria, quantidade em estoque. Clicar **Cadastrar**. Alternativa: clicar em um card existente → **Editar medicamento** no modal de detalhes → salvar.
- **Fala:** “Demonstramos a manutenção do estoque em tempo real, algo relevante para transparência na rede pública.”

Cena 19 — Indisponível e parceira

- **Tela:** Medicamentos — card com status indisponível ou estoque zero.
- **Ação:** Clicar no card. No modal de detalhes, apontar link/mensagem para unidades parceiras. Opcional: voltar, menu **Unidades parceiras**, clicar em outra unidade para ver medicamentos **somente leitura** (sem editar).
- **Fala:** “Quando o item não está disponível aqui, a unidade pode orientar a busca em parceiras — sem quebrar o isolamento de edição entre unidades.”

Cena 20 — Passagem

- **Tela:** Qualquer tela autenticada do admin.
 - **Ação:** Olhar para Matheus. [APOIO] Fazer logout do admin (menu ou limpar sessão) **ou** trocar para aba já autenticada como enfermeiro.
 - **Fala:** “Com a camada de gestão demonstrada, o Matheus assume o perfil de enfermagem e a operação de triagem.”
-

Matheus Chagas (2 minutos e 30 segundos)

Cena 1 — Login enfermeiro

- **Tela:** Tela de login (/) — ou aba já autenticada como enfermeiro.
- **Ação:** Efetuar login com o perfil de enfermagem, se necessário.
- **Fala:** “Assumo o perfil de enfermagem, *na tela de login*, para mostrar a operação de triagem na unidade.”

Cena 2 — Dashboard e fila

- **Tela:** Dashboard do enfermeiro (/auth/dashboard) — card da fila de triagem.
- **Ação:** Apontar pacientes em `Aguardando triagem`. Citar botão único **Iniciar triagem** (não há ação por linha). Opcional rápido: apontar botão **Presencial** (“cadastrar paciente sem celular”).
- **Fala:** “A fila mostra casos da mesma unidade ainda sem enfermeiro atribuído. O botão *Iniciar triagem* faz o claim atômico: evita que dois profissionais peguem o mesmo paciente.”

Cena 3 — Claim e abertura da triagem

- **Tela:** Dashboard do enfermeiro.
- **Ação:** Clicar **Iniciar triagem**. Aguardar redirecionamento para `/auth/triage/:attendanceId`.
- **Fala:** “Ao iniciar, o sistema atribui o caso a mim e abre o detalhe da triagem.”

Cena 4 — Revisar pré-atendimento

- **Tela:** Detalhe da triagem — seção de queixa, sintomas, dor, dados declarados pelo paciente.
- **Ação:** Rolar devagar. Apontar queixa principal e tags de sintomas.
- **Fala:** “A enfermagem recebe o que o paciente já informou no pré-atendimento, reduzindo repetição de perguntas na recepção.”

Cena 5 — Sinais vitais e risco

- **Tela:** Detalhe da triagem — cards de sinais vitais editáveis e seletor de classificação de risco.
- **Ação:** Preencher ou ajustar: temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, escala de dor. Selecionar nível de risco (ex.: Urgente). Preencher observação breve se houver campo.
- **Fala:** “Registramos sinais vitais estruturados e a classificação de risco, padronizando a passagem para o médico.”

Cena 6 — Concluir triagem

- **Tela:** Detalhe da triagem — botão **Concluir triagem** no topo.
- **Ação:** Clicar **Concluir triagem**. No modal de confirmação, revisar resumo. Clicar **Confirmar e concluir triagem**. Aguardar sucesso.
- **Fala:** “Ao concluir, o status vai para aguardando atendimento médico — o caso entra na fila do médico da mesma unidade.”

Cena 7 — Histórico de triagens

- **Tela:** Menu lateral → **Histórico de triagens** (`/auth/triages`).
- **Ação:** Mostrar lista com data “Triado em”. Clicar em uma linha se quiser reabrir detalhe em leitura.
- **Fala:** “O enfermeiro acompanha o histórico das triagens que realizou, com rastreabilidade.”

Cena 8 — Configurações

- **Tela:** **Configurações** na sidebar — `ConfigModal`.
- **Ação:** Abrir e mostrar campo de local de trabalho / dados profissionais. Fechar.
- **Fala:** “O perfil também mantém local de triagem, usado depois para avisar o paciente onde se dirigir.”

Cena 9 — Passagem

- **Tela:** Dashboard ou menu.
 - **Ação:** [APOIO] Trocar para aba do médico ou logout/login com perfil médico.
 - **Fala:** “Triagem concluída. O Rafael Silva assume a consulta médica.”
-

Rafael Silva (2 minutos e 30 segundos)

Cena 1 — Login médico

- **Tela:** **Tela de login** ou sessão médico.
- **Ação:** Efetuar login com o perfil médico.
- **Fala:** “No perfil médico, *na tela de login*, continuamos o mesmo episódio que acabou de sair da triagem.”

Cena 2 — Fila médica

- **Tela:** **Dashboard do médico** (`/auth/dashboard`).
- **Ação:** Apontar fila **Aguardando atendimento**. Clicar **Iniciar atendimento**.
- **Fala:** “Mesma lógica de claim: um médico por caso, atribuição atômica na fila.”

Cena 3 — Detalhe do atendimento — contexto

- **Tela:** **Detalhe do atendimento** (`/auth/attendance/:attendanceId`).
- **Ação:** Mostrar dados da triagem: vitais, risco, sintomas, queixa.
- **Fala:** “O médico recebe continuidade clínica — não recomeça do zero.”

Cena 4 — Sugestões por regras

- **Tela:** **Detalhe do atendimento** — coluna lateral **Condições sugeridas**.
- **Ação:** Aguardar carregar cards com nome da doença e percentual de compatibilidade. Clicar em uma condição para abrir modal **Detalhes da Sugestão**.
- **Fala:** “As sugestões são *IA simbólica*: pesos de sintomas na base curada, compatibilidade em percentual. Não é modelo generativo e **não é diagnóstico automático**.”

Cena 5 — Detalhe da sugestão

- **Tela:** Modal **Detalhes da Sugestão**.
- **Ação:** Apontar sintomas de referência, medicamentos e exames sugeridos na base. Fechar modal.
- **Fala:** “O médico usa isso como apoio à decisão, com transparência sobre o que foi considerado.”

Cena 6 — Finalizar atendimento

- **Tela:** Detalhe do atendimento — botão Finalizar atendimento.
- **Ação:** Clicar Finalizar atendimento. No modal: selecionar diagnóstico da lista (diagnosisKey da base). Preencher texto de diagnóstico se opcional. Definir destino do paciente. Adicionar prescrição de medicamento e/ou exame se o modal permitir. Confirmar envio. Aguardar sucesso.
- **Fala:** “A conclusão exige diagnóstico alinhado ao catálogo de doenças — amarrando regra de negócio e registro clínico estruturado.”

Cena 7 — Resumo concluído

- **Tela:** Detalhe do atendimento — seção Resumo do atendimento (status concluído).
- **Ação:** Apontar diagnóstico, prescrições, exames, data de conclusão.
- **Fala:** “O episódio fica fechado com rastreabilidade para histórico e indicadores.”

Cena 8 — Histórico

- **Tela:** Menu → Histórico de atendimentos (/auth/attendances).
- **Ação:** Mostrar lista. Opcional: reabrir um atendimento concluído.
- **Fala:** “O médico consulta atendimentos anteriores pelos quais foi responsável.”

Cena 9 — Configurações e passagem

- **Tela:** Configurações — mostrar workLocationLabel (consultório).
- **Ação:** Fechar. [APOIO] Trocar para aba do paciente ou logout/login com perfil paciente (sem atendimento ativo pendente).
- **Fala:** “Encerro o bloco clínico. O Victor mostra a jornada do paciente — onde o fluxo começa de fato.”

| Victor Campos (3 minutos e 45 segundos)

Cena 1 — Login paciente

- **Tela:** Tela de login.
- **Ação:** Efetuar login com o perfil paciente. Confirmar que **não** há atendimento ativo pendente no dashboard antes de criar novo.
- **Fala:** “Fechamos com o paciente, *na tela de login* — o ponto onde a jornada costuma começar fora da unidade.”

Cena 2 — Cadastro público (opcional, 30 s)

- **Tela:** Fazer logout. Abrir /sign-up pelo link Cadastrar-se.
- **Ação:** Percorrer campos principais (unidade, dados pessoais). Pode **não** submeter se o tempo apertar.
- **Fala:** “Qualquer pessoa pode criar conta de paciente em *Cadastrar-se*, vinculando-se a uma unidade da rede.”

Cena 3 — Login paciente novamente

- **Tela:** Tela de login.
- **Ação:** Entrar com a conta de demonstração já vinculada à unidade.
- **Fala:** “Uso uma conta de demonstração já vinculada à unidade para o pré-atendimento ao vivo.”

Cena 4 — Pré-cadastro

- **Tela:** Menu ou atalho → Pré-Cadastro (/auth/pre-registration).

- **Ação:** Preencher queixa principal (ex.: “Febre e dor de garganta há dois dias”). Data de início dos sintomas. Nível de dor (ex.: 6). Selecionar sintomas nas tags (febre, dor de garganta, etc.). Preencher observação se desejar. Clicar **Finalizar pré-cadastro**.
- **Fala:** “O paciente registra o pedido de atendimento antes de chegar fisicamente, com sintomas estruturados para a triagem.”

Cena 5 — Confirmação no modal

- **Tela:** Modal **Confirmação de consulta**.
- **Ação:** Revisar resumo. Clicar **Confirmar consulta**. Aguardar redirecionamento ao dashboard com mensagem de sucesso.
- **Fala:** “O status inicial é *a caminho* — o paciente ainda não entrou na fila da enfermagem.”

Cena 6 — Dashboard paciente — chegada

- **Tela:** **Dashboard do paciente** (/auth/dashboard) — card do atendimento ativo.
- **Ação:** Apontar status “A caminho”. Clicar **Confirmar chegada ao hospital**. Aguardar atualização para aguardando triagem.
- **Fala:** “Ao confirmar a chegada, *na tela do dashboard do paciente*, o caso entra na fila operacional da unidade — conectando o que vimos no admin, na enfermagem e no médico.”

Cena 7 — Acompanhamento

- **Tela:** **Dashboard do paciente** — mensagem de jornada / aviso de local se já houver claim posterior (mencionar que atualiza quando profissional assume).
- **Ação:** Mostrar status atual. Opcional: abrir **Editar pré-atendimento** se disponível no card.
- **Fala:** “O paciente acompanha o andamento sem repetir dados já informados — menos fricção na porta da unidade.”

Cena 8 — Configurações do paciente

- **Tela:** **Configurações** — ConfigModal.
- **Ação:** Mostrar dados de saúde (alergias, condições). Fechar.
- **Fala:** “O paciente também atualiza seus dados de perfil de forma autônoma.”

Cena 9 — Encerramento final

- **Tela:** Slide de encerramento ou dashboard paciente.
- **Ação:** Toda a equipe pode se posicionar junto. Olhar para a banca.
- **Fala:** “Concluimos a demonstração do **MedIT** em vinte minutos: contexto e arquitetura nos slides; na prática, gestão por unidade, cadastro de equipe, triagem estruturada, consulta com apoio por regras, medicamentos e a jornada do paciente de ponta a ponta. O sistema não substitui o profissional de saúde — organiza o fluxo e apoia a decisão. Agradecemos a atenção da banca e ficamos à disposição para perguntas.”
- **[APOIO]** Fim da apresentação. Equipe preparada para demo de backup em perguntas (reabrir um atendimento concluído no histórico médico, se solicitado).